辽宁中医杂志
Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine
ISSN 1000-1719,CN 21-1128/R

《辽宁中医杂志》网络首发论文

题目：　天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍语言功能异常的临床观察
作者：　廖昊森，林亚明
网络首发日期：　2026-02-12
引用格式：　廖昊森，林亚明．天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍语言功能异常的临床观察[J/OL]．辽宁中医杂志．
https://link.cnki.net/urlid/21.1128.r.20260211.1136.031

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-02-12 08:50:37　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1128.r.20260211.1136.031

天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍语言功能异常的临床观察

廖昊森[1] 林亚明[2]✉

（1.硕士，云南中医药大学第一临床医学院，云南，昆明，65600；2.博士，云南中医药大学第一附属医院，云南，昆明，65600）

【摘要】：目的：观察天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍-语言功能异常辨证属于髓海不足证者的临床观察。**方法：**将 84 例患者随机分为治疗组和对照组。治疗组服用天麻醒脑胶囊；对照组服用盐酸多奈哌齐。在治疗前及治疗后第 12、24 周，用简易精神状态检查（Mini-Mental State Examination, MMSE）和蒙特利尔认知评估量表（Montreal Cognitive Assessment, MoCA）评估患者整体认知及改善情况，使用波士顿命名测验 30 项（Boston Naming Test 30-item，BNT-30）、词语流畅性测验（Verbal Fluency Test, VFT）评估患者语言功能及改善情况，使用痴呆中医证候变化总体印象量表评估患者中医证候及改善情况。**结果：**①在治疗 3 个月和 6 个月时,两组患者的 MMSE、MoCA、BNT-30 和 VFT 评分，与治疗前相比均有显著提升，P<0.05；组间同期比较相近，P>0.05。②在治疗 3 个月后，治疗组痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者及家属）中，仅倦怠嗜卧评分明显优于对照组，P<0.05；医师评估方面仅舌淡瘦小和总体印象评分优于对照组，P<0.05。③在治疗 6 个月后，治疗组中医证候变化总体印象量表评分（患者及家属）中，仅行动笨拙（患者）评分和对照组比较相近，P>0.05；医师评估方面则脉沉细、舌淡瘦小和总体印象均优于对照组，P<0.05。**结论：**①天麻醒脑胶囊在改善血管性轻度认知障碍患者 MMSE、MoCA、BNT-30 和 VFT 评分方面，疗效不劣于盐酸多奈哌齐；②天麻醒脑胶囊能有效改善血管性轻度认知障碍患者的中医证候评分分值和临床疗效；③使用天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍及语言功能异常，口服 6 个月的疗程效果明显优于 3 个月的疗程效果。

【关键词】：血管性轻度认知障碍；语言功能障碍；天麻醒脑胶囊；多奈哌齐

[基金项目]：云南省中医药临床重点学科中医脑病学建设项目：30372103700

[第一作者]：廖昊森（1996-），男，汉族，云南昆明，住院医师，硕士研究生，研究方向：从事脑病的中医防治与研究

[通信作者]：林亚明（1961-），男，汉族，云南昆明，主任医师，硕士生导师，博士，研究方向：从事脑病的中医防治与研究，

截至 2019 年，我国 60 岁以上的人口占总人口的 17.9%，已进入老龄化社会，其中阿尔茨海默病（Alzheimer's disease，AD）患者约占比 3.9%，血管性痴呆（Vascular Dementia, VaD）患者约 1.6%，轻度认知障碍（Mild Cognitive Impairment，MCI）的患病率则高达 15.5%[1]。MCI 作为无认知障碍到痴呆的过渡阶段，将主要干预措施集中在 MCI 患者上，可有效预防痴呆并降低其所带来的社会及经济负担[1]。在血管性认知障碍（Vascualr Cognitive Impairment，VCI）的治疗中，中医药的干预治疗被认为是有效且合适的治疗方案，可以提高临床治疗质量[2]。我们团队的既往研究[3-6]发现天麻醒脑胶囊能有效改善 VCI 及 VaD 患者的认知损害，并在改善中医证候评分中效果明显，但对天麻醒脑胶囊治疗血管性轻度认知障碍（Vascular Mild Cognitive Impairment，VaMCI）语言功能异常是否有效而不知，经文献查新无相同报道而立题研究，采用前瞻随机对照方法，以盐酸多奈哌齐为阳性对照，观察天麻醒脑胶囊治疗 VaMCI 语言功能异常的临床疗效如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

本研究采用随机对照的方法，纳入 2022 年 10 月至 2023 年 1 月期间在云南省中医医院神经内科门诊和住院部诊断为 VaMCI 的患者共 84 例，根据随机数字对照表分为治疗组和对照组，其中治疗组 43 例，对照组 41 例。两组患者年龄及病程数据经 t 检验后，无显著差异；两组患者性别、受教育程度计数数据经秩和检验无显著差异，两组患者在年龄、病程、性别及教育程度均具有可比性。

1.2 诊断方法

1.2.1 中医诊断标准—参照中国痴呆诊疗指南（2017 版）[7]的诊断标准：①主诉智能缺损；②存在一项或以上明显的智能缺损；③日常生活能力下降，部分受累甚至完全丧失；④除外引起智能缺损的其他原因。髓海不足证：动作缓慢，多忘不精，脑转耳鸣，胫酸眩冒、两目昏花，齿枯发焦，舌瘦淡红、脉沉细。

1.2.2 西医诊断标准—参照《2019年中国血管性认知障碍诊治指南》[8]的诊断标准：①存在认知损害；②存在血管性脑损伤的证据；③明确血管性脑损害在认知损害中占主导地位；④VaMCI存在1个或多个认知域的功能障碍，不影响日常生活的独立性，但是为了保持独立性，需要付出更大的努力或代偿性措施。

1.2.3 语言功能异常—参照《2019年中国血管性认知障碍诊治指南》[8]的诊断标准：①BNT-30≤22分（总分30分）；②VFT<14分。

1.3　纳入标准

①符合中西医诊断标准；②符合语言功能异常的患者；③文化水平为小学三年级以上；④年龄≤75 岁并不伴有失明或上肢不能活动的患者。

1.4　排除标准

①参与者在过去1个月内参与或完成其它相关药物的临床试验；②日常生活能力低下而不能完成相关量表评分的患者；③精神或情绪障碍患者；④对研究所使用的药物过敏，或依从性较差的患者。

1.5　治疗方案

对照组予盐酸多奈哌齐（5mg*7s；10mg*7s 重庆植恩药业有限公司；批准文号 国药准字 H20010723）口服，5mg/次，每晚一次，1 月后改为 10mg/次；治疗组予天麻醒脑胶囊（0.4g/粒 云南永孜堂制药有限公司；批准文号 国药准字 Z20027062）口服，1.2g/次，一日三次。

1.6　疗效判定标准

分别于入组前，治疗后 12 周（±4 天），24 周（±4 天）进行神经心理学量表评分，评估疗效。

（1）呆病的中医证候分级及记分[9,10]：临床缓解：疗效指数 ≥95%，表示用药前后症状和体征有极为显著的改善：显效：疗效指数 70%-94%，症状和体征有显著改善；有效：疗效指数 30%-69%，症状和体征有一定程度的改善；无效：疗效指数 ＜30%，症状和体征无明显改善或恶化。

（2）西医以 MMSE、MoCA、BNT-30、VFT 评分标准进行疗效评定[11-13]：显效：疗效指数 ≥20%，表示治疗后有显著改善；有效：疗效指数 ≥12%，症状和体征有改善；无效：疗效指数 ≤12%，症状和体征改善不明显；恶化：疗效指数 ≤-12%，症状和体征出现恶化。

1.7　观察指标

（1）　使用 MoCA、MMSE 衡量患者整体认知功能及改善程度。

（2）　使用 BNT-30、VFT 评估患者语言能力及改善情况。

（3）　使用痴呆中医证候变化总体印象量表观察患者中医证候及变化情况。

1.8　统计学处理

所有量表数据结果采用 SPSS 27.0 软件进行统计分析，计量资料符合正态分布采用 t 检验，符合偏态分布的采用 U 检验。用均数±标准差($\bar{x}$±s)表示。计数资料以百分数(%)表示，采用 χ^2 检验。等级资料可以采用秩和检验、redite 检验。

2．结果

2.1 两组 MMSE 量表评分比较

表 1 两组 MMSE 评分比较

组别	例数	治疗前	治疗 12 周 ±4 天	治疗 24 周 ±4 天	治疗 3 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗 3 个月
治疗组	43	28（27，29）	30（29，30）	30（29，30）	Z=-4.983 P=0.000	Z=-5.045 P=0.000	Z=-2.121 P=0.034
对照组	41	28（27，29）	29（28，30）	30（28，30）	Z=-4.599 P<0.001	Z=-4.903 P<0.001	Z=-2.887 P=0.004
		Z=-0.383 P=0.702	Z=-1.828 P=0.68	Z=-1.263 P=0.207			

两组患者治疗 3 个月、6 个月后与治疗前相比，MMSE 量表评分均显著改善 P<0.001，同期组间比较无明显差异 P＞0.05。

2.2 两组患者的 MoCA 量表评分比较

表 2 两组 MoCA 量表评分比较

组别	例数	治疗前	治疗 12 周 ±4 天	治疗 24 周 ±4 天	治疗 3 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗 3 个月
治疗组	43	23（23，24）	26（25，27）	26（25，27）	Z=-6.024 P=0.000	Z=-5.998 P=0.000	Z=-1.732 P=0.083
对照组	41	23（22，24）	26（25，27）	26（25，27）	Z=-5.724 P=0.000	Z=-5.787 P=0.000	Z=-2.646 P=0.008
		Z=-0.258 P=0.797	Z=-0.961 P=0.337	Z=-0.632 P=0.528			

两组患者在治疗 3 个月、6 个月后，同期组间比较无明显差异 P＞0.05；与治疗前相比，MoCA 量表评分均显著改善 P=0.000；治疗组在治疗 6 个月后与治疗 3 个月后比较无明显差异 P＞0.05，而对照组在治疗 6 个月后与治疗 3 个月后比较有明显差异 P＜0.05。

2.3 两组患者 BNT-30 评分比较

表 3 两组 BNT-30 量表评分比较

组别	例数	治疗前	治疗 12 周 ±4 天	治疗 24 周 ±4 天	治疗 3 个月	治疗 6 个月	治疗 6 个月

					- 治疗前	- 治疗前	- 治疗 3 个月
治疗组	43	20（20，21）	22（21，23）	23（22，24）	Z=-5.612 P=0.000	Z=-6.032 P=0.000	Z=-5.588 P=0.000
对照组	41	20（20，21）	21（20，22）	23（22，24）	Z=-4.700 P=0.000	Z=-5.789 P=0.000	Z=-4.980 P=0.000
		Z=-1.025 P=0.306	Z=-1.152 P=0.249	Z=-1.092 P=0.275			

两组患者在治疗 3 个月、6 个月后，与治疗前相比，患者 BNT-30 量表评分均有效改善（P=0.000），同期组间比较无明显差异。

2.4 两组患者 VFT 评分比较

表 4 两组 VFT 量表评分比较

组别	例数	治疗前	治疗 12 周 ±4 天	治疗 24 周 ±4 天	治疗 3 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗前	治疗 6 个月 - 治疗 3 个月
治疗组	43	11（10，11.5）	12（11，13）	13（12，13.5）	Z=-5.246 P=0.000	Z=-5.901 P=0.000	Z=-4.750 P=0.034
对照组	41	11（10，12）	12（11，13）	13（12，14）	Z=-5.372 P=0.000	Z=-5.623 P=0.000	Z=-4.278 P=0.000
		Z=-0.142 P=0.887	Z=-0.440 P=0.660	Z=-0.204 P=0.838			

两组患者在治疗 3 个月、6 个月后，与治疗前相比，患者 VFT 量表评分均显著改善 P=0.000；同期组间比较无明显差异 P＞0.05。

2.5 痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者及家属以及医师评估）比较（见下表 5～表 7）

表 5 痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者、家属及医师评估）基线期比较

中医症候	组别	无	轻度	轻中	中度	中重	重度	极重	X^2	P
肢胫酸楚（患者）	治疗组		1	13	16	11	2		8.653	0.070
	对照组		4	3	17	15	2			
肢胫酸楚（家属）	治疗组		2	8	18	13	1	1	3.686	0.595
	对照组		1	6	15	12	4	3		
齿枯发焦（患者）	治疗组		5	24	14				3.181	0.204
	对照组		6	15	20					

齿枯发焦（家属）	治疗组		8	23	11	1			1.428	0.699
	对照组		6	22	13	0				
行动笨拙（患者）	治疗组	6	13	17	7				3.053	0.384
	对照组	7	16	9	9					
行动笨拙（家属）	治疗组	5	17	15	6				1.384	0.709
	对照组	6	15	11	9					
倦怠嗜卧（患者）	治疗组	1	9	30	3				1.219	0.748
	对照组	0	7	31	3					
倦怠嗜卧（家属）	治疗组		12	21	10				4.713	0.099
	对照组		4	23	14					
头晕耳鸣（患者）	治疗组		5	32	6				5.529	0.063
	对照组		6	21	14					
头晕耳鸣（家属）	治疗组		9	23	11				0.574	0.751
	对照组		6	24	11					
脉沉细（医师）	治疗组	4	8	7	6	9	4	5	4.685	0.608
	对照组	8	4	8	9	5	3	4		
舌淡瘦小（医师）	治疗组	5	10	9	11	8			6.381	0.175
	对照组	11	5	11	5	9				
总体印象（医师）	治疗组	7	7	9	11	9			1.674	0.815
	对照组	10	7	10	7	7				

两组患者在治疗前的痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者、家属及医师评估）在统计学上无差异，P＞0.05，具有可比性。

表 6 痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者、家属及医师评估）治疗 3 个月比较

中医症候	组别	无	轻度	轻中	中度	中重	重度	极重	X^2	P
肢胫酸楚（患者）	治疗组	1	20	20	1	1			6.456	0.168
	对照组	1	12	20	7	1				
肢胫酸楚（家属）	治疗组	2	16	21	4				8.878	0.114
	对照组		14	16	5	3	3			
齿枯发焦（患者）	治疗组	8	24	11	0				5.532	0.137
	对照组	4	21	12	4					
齿枯发焦（家属）	治疗组	4	28	9	2	0			3.431	0.330
	对照组	4	19	14	4	0				
行动笨拙（患者）	治疗组	15	27	1	0				3.829	0.280
	对照组	16	20	4	1					
行动笨拙（家属）	治疗组	19	22	2					2.807	0.246
	对照组	11	28	2						
倦怠嗜卧（患者）	治疗组	7	29	7	0				9.317	0.025
	对照组	2	23	11	5					
倦怠嗜卧	治疗组	8	28	7	0				8.848	0.031

（家属）	对照组	2	23	13	3					
头晕耳鸣	治疗组		5	27	11				3.357	0.340
（患者）	对照组		5	20	14	2				
头晕耳鸣	治疗组	4	31	7	1				4.535	0.209
（家属）	对照组	3	22	15	1					
脉沉细	治疗组	12	17	8	6	0	0	0	7.871	0.154
（医师）	对照组	9	11	12	4	3	2	0		
舌淡瘦小	治疗组	14	17	12	0				10.141	0.014
（医师）	对照组	12	7	17	5					
总体印象	治疗组	22	20	1	0	0			19.808	＜
（医师）	对照组	10	14	13	3	1				0.001

表 7 痴呆中医证候变化总体印象量表评分（患者及家属）治疗 6 个月比较

中医症候	组别	无	轻度	轻中	中度	中重	重度	极重	X^2	P
肢胫酸楚	治疗组	11	24	7	1	0	0		14.226	0.007
（患者）	对照组	2	17	18	3	1	0			
肢胫酸楚	治疗组	7	23	13					11.112	0.049
（家属）	对照组	2	20	11	3	2	3			
齿枯发焦	治疗组	16	21	6	0				7.927	0.039
（患者）	对照组	6	25	7	3					
齿枯发焦	治疗组	17	25	1	0	0			16.898	0.001
（家属）	对照组	5	23	12	11	0				
行动笨拙	治疗组	28	15	0	0				5.149	0.076
（患者）	对照组	19	19	3	0					
行动笨拙	治疗组	31	12						10.682	0.001
（家属）	对照组	15	26							
倦怠嗜卧	治疗组	18	22	3	0				12.359	0.006
（患者）	对照组	6	22	12	1					
倦怠嗜卧	治疗组	23	19	1	0				27.732	0.001
（家属）	对照组	2	28	9	2					
头晕耳鸣	治疗组	15	25	3					9.465	0.009
（患者）	对照组	7	21	13						
头晕耳鸣	治疗组	19	24	0	0				20.130	0.001
（家属）	对照组	5	24	1	1					
脉沉细	治疗组	26	13	3	1	0	0	0	17.923	＜
（医师）	对照组	9	14	9	5	4	0	0		0.001
舌淡瘦小	治疗组	28	15	0	0				21.786	＜
（医师）	对照组	13	12	12	4					0.001
总体印象	治疗组	27	15	1	0	0			19.291	＜
（医师）	对照组	13	13	13	2	0				0.001

痴呆中医证候变化总体印象量表评分结果表明：①治疗 3 个月后，治疗组患者及家属评分中，仅倦怠嗜卧评分明显优于对照组；医师评估方面仅舌淡瘦小和总体印象评分优于对照组；②在治疗 6 个月后，治疗组患者及家属评分中，仅行动笨拙（患者）评分和对照组比较无明显差异；医师评估方面则脉沉细、舌淡瘦小和总体印象均优于对照组。

3. 讨论

中医认为 VCI 属于“呆病”范畴，症状包括记忆力减退和反应迟钝。病机核心为“虚”（肾精不足）、“痰”（脾胃失调）、“瘀”（血液循环障碍），导致髓海不足，神机失用，治疗着重于补肾益髓、化痰通络，以恢复大脑功能[14–16]。临床研究[14,17]表明，采用中医辨证施治，如补肾健脾、活血化痰等方法，对 VaMCI 患者有明显疗效。语言功能障碍是由脑损伤引起的语言丧失或损伤，是中风病最具破坏性的认知障碍之一[18]。

天麻醒脑胶囊是一种中药制剂，由天麻、地龙、石菖蒲、远志、熟地黄和肉苁蓉组成，具有滋补肝肾、通络止痛的功效[3,19]。研究显示天麻通过抑制 β-淀粉样蛋白（Aβ）和 Tau 蛋白异常磷酸化，降低氧化应激，激活 PI3K/AKT/mTOR 通路，改善突触功能等方式改善 VaD 大鼠的认知功能[20-22]。研究[23]发现远志皂苷可通过调控 Aβ 转运蛋白的表达并加快其清除，抑制神经细胞凋亡，发挥抗 Aβ 神经毒性及神经保护作用。研究[24]证实熟地黄能下调 TF、TFR1 的表达，减少细胞对铁离子的摄入，抑制铁过载及铁死亡，减轻缺血性脑卒中的脑损伤，改善卒中后认知功能障碍。肉苁蓉总苷可降低 Aβ 表达，抑制乙酰胆碱酶的活性，发挥神经保护作用[25]。

临床研究[4,5]表明，天麻醒脑胶囊在针对 VCI 和 VaD 的治疗研究中，能够有效改善患者的认知功能，包括记忆力、注意力和执行能力，与对照组相比，服用天麻醒脑胶囊的患者在接受相关认知功能评估时，如阿尔茨海默病评定量表、血管性痴呆辨证量表、MoCA 和 MMSE，均表现出更高的得分提升，但天麻醒脑胶囊治疗 VaMCI 语言功能异常的临床研究尚未见报道。

本文将 84 例 VaMCI 患者随机分为治疗组和对照组。治疗组服用天麻醒脑胶囊；对照组服用盐酸多奈哌齐。在治疗前及治疗后第 12、24 周，用 MMSE、MoCA 评估患者整体认知及改善情况，使用 BNT-30、VFT 评估患者语言功能及改善情况，使用痴呆中医证候变化总体印象量表评估患者中医证候及改善情况。结果发现天麻醒脑胶囊在改善 VaMCI 患者 MMSE、MoCA 、BNT-30 和 VFT 评分上疗效不劣于盐酸多奈哌齐；能有效改善 VaMCI 患者的中医证候评分分值和临床疗效，且口服 6 个月的疗程效果明显优于 3 个月的疗程效果。

综上所述，从临床实验的结果、中医理论对该病病因病机的认识、天麻醒脑胶囊的药学和药效学研究都证明了该药对 VaMCI 语言功能异常有治疗效果，值得深入研究。

4. 结论

天麻醒脑胶囊能有效改善 VaMCI 语言功能异常髓海不足证的临床疗效和中医证候；天麻醒脑胶囊在改善 MMSE、MoCA、BNT-30 和 VFT 评分上不劣于盐酸多奈哌齐；使用天麻醒脑胶囊治疗 VaMCI 语言功能异常患者，6 个月的疗程效果明显优于 3 个月的疗程。

参考文献：

[1] JIA L, DU Y, CHU L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study[J]. The Lancet. Public Health, 2020, 5(12): e661-e671.

[2] MASSERINI F, BASO G, GENDARINI C, et al. Therapeutic strategies in vascular cognitive impairment: A systematic review of population, intervention, comparators, and outcomes[J]. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 2023, 19(12): 5795-5804.

[3] 林亚明, 陈维, 胡璘媛, 等. 天麻醒脑胶囊治疗血管性认知功能障碍、神经性头痛临床应用专家共识[J]. 中华中医药学刊, 2021, 39(8): 255-258.

[4] 来建明, 林亚明. 天麻醒脑胶囊治疗血管性认知功能障碍临床观察[J]. 光明中医, 2016, 31(21): 3127-3130.

[5] 陈维, 胡璘媛, 林亚明. 天麻醒脑胶囊治疗轻中度血管性痴呆(肝肾不足、肝风上扰证)的随机、双盲、平行对照、多中心临床研究[J]. 安徽中医药大学学报, 2021, 40(1): 30-34.

[6] 易魁. 天麻醒脑胶囊治疗中风并呆病（血管性轻度认知障碍）髓海不足证的临床观察[D]. 云南中医药大学, 2024.

[7] 田金洲. 中国痴呆诊疗指南[M]. 2017 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.

[8] 中国医师协会神经内科分会认知障碍专业委员会,《中国血管性认知障碍诊治指南》编写组. 2019 年中国血管性认知障碍诊治指南[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(35): 2737-2744.

[9] 余家伟.谷红注射液治疗非痴呆型血管性认知障碍的临床研究[D].安徽中医药大学,2017.

[10] 杨元庆,张智龙,薛莉,等.定志益聪颗粒对血管性痴呆患者认知功能障碍影响的临床研究[J].时珍国医国药,2016,27(09):2196-2198.

[11] HUIQIN Z, HANQING C, HUI P, et al. The Effect of Guilingji Capsules on Vascular Mild Cognitive Impairment: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial [J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2022, 2022 4778163-4778163.

[12] HAEYOON K, KYUNGHO Y, BYUNGCHUL L, et al. Validity of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Index Scores: a Comparison with the Cognitive Domain Scores of the Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB). [J]. Dementia and neurocognitive disorders, 2021, 20 (3): 28-37.

[13] YU L, JIABIN S, QIHAO G, et al. Regional Gray Matter Atrophy in Vascular Mild Cognitive Impairment. [J]. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 2016, 25 (1): 95-101.

[14] 刘立瑾, 王建军, 郑浩涛, 等. 虢周科基于"脾肾亏虚,痰瘀阻络"论治血管性轻度认知障碍经验[J]. 广州中医药大学学报, 2020, 37(6): 1159-1163.

[15] 王玉兴. 证治准绳精编[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2015.
[16] 朱震亨. 丹溪心法[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1997.
[17] 张莹."补肾益髓化痰通络法"治疗血管性轻度认知损害（肾精亏虚，痰浊瘀血证）的临床研究[D]. 长春中医药大学, 2023.
[18] BERTHIER M L. Poststroke aphasia : epidemiology, pathophysiology and treatment[J]. Drugs & Aging, 2005, 22(2): 163-182.
[19] 国家药典委员会编. 中华人民共和国药典 一部 2020 年版[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.
[20] YU A, ZHANG T, DUAN H, et al. MiR-124 contributes to M2 polarization of microglia and confers brain inflammatory protection via the C/EBP-α pathway in intracerebral hemorrhage[J]. Immunology Letters, 2017, 182: 1-11.
[21] HENRY R J, DORAN S J, BARRETT J P, et al. Inhibition of miR-155 Limits Neuroinflammation and Improves Functional Recovery After Experimental Traumatic Brain Injury in Mice[J]. Neurotherapeutics: The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 2019, 16(1): 216-230.
[22] ZHANG Y, HUANG H, YAO C, et al. Fresh Gastrodia elata Blume alleviates simulated weightlessness-induced cognitive impairment by regulating inflammatory and apoptosis-related pathways[J]. Frontiers in Pharmacology, 2023, 14: 1173920.
[23] 余河汉, 陆晓华, 金桂芳, 等. 远志皂苷调控 Aβ 转运抑制神经细胞周期活化及细胞凋亡的作用[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(17): 4310-4314.
[24] 李赛菲, 袁培培, 魏亚新, 等. 熟地黄通过抑制自噬和铁死亡改善缺血性脑卒中大鼠神经功能损伤[J]. 中国实验方剂学杂志, 2024, 30(8): 26-33.
[25] 王璐, 吴丽娥, 贾建新. 肉苁蓉的药理作用及其在中枢神经系统疾病中的研究进展[J]. 中华中医药学刊, 2024, 42(3): 50-54.